

KIREO

Orientamento. Direzione. Futuro.

REFERENTE ISTITUZIONALE

Fondi PNRR e autorizzazioni

Il kit del referente istituzionale

Materiale didattico — Workshop KIREO

Apri un'enoteca a Centocelle, Roma

Cosa devi produrre

La dottoressa ha sentito parlare di fondi PNRR ma non sa da dove si comincia. Ha un immobile comunale in comodato e una gran voglia di fare. Il tuo lavoro è dirle quali soldi può chiedere davvero, con che scadenze, e cosa succede quando il PNRR finisce.

La consegna richiesta

- Fondi realmente accessibili, con misura e scadenza
- Requisiti autorizzativi per aprire il presidio
- Inquadramento del comodato dell'immobile comunale
- Piano di sostenibilità dopo la fine del PNRR

La Missione 6 del PNRR in numeri

La Componente 1 della Missione 6 finanzia reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza territoriale. A giugno 2025 contava oltre 2.700 progetti per 6,96 miliardi di euro. Questi sono i numeri con cui hai a che fare.

Misura	Finanziamento	Interventi	Importo medio
Casa come primo luogo di cura e telemedicina	€ 3,9 mld	949	€ 4,1 mln
Case della Comunità	~€ 2 mld	—	—
Ospedali di Comunità	~€ 1 mld	—	—
Totale Missione 6 C1	€ 6,96 mld	2.700+	

Fonte: elaborazione IFEL su dati Italia Domani, dati al 30 giugno 2025. Decreti di ripartizione risorse telemedicina: DM 28 settembre 2023 e DM 19 febbraio 2025.

Il punto critico: i fondi non li chiedi tu

Questo è il passaggio che devi spiegare bene alla dottoressa. I fondi PNRR della Missione 6 sono **ripartiti alle Regioni**, che poi li assegnano alle ASL per progetti specifici. Un medico di base non presenta domanda al Ministero: deve entrare nella programmazione regionale attraverso la propria ASL.

- La Regione approva un piano operativo con l'elenco delle Case di Comunità da realizzare
- L'ASL è il soggetto attuatore degli interventi sul territorio
- Il medico di base può proporre e sostenere il progetto, ma non è il beneficiario diretto
- Il Comune, con l'immobile in comodato, diventa un partner essenziale della proposta

Gli altri canali di finanziamento

Il PNRR non è l'unica strada, ed è anche quella con la scadenza più vicina. Per le aree interne esistono strumenti dedicati e strutturali.

Strumento	Cosa finanzia	Dotazione
Strategia Nazionale Aree Interne	Servizi essenziali: sanità, scuola, mobilità	2,3 mln € FSC + 1,7 mln € fondo rotazione per area
Piano Strategico Nazionale Aree Interne	Interventi su territori in spopolamento	310 mln € aggiuntivi, integrabili con PNRR e fondi UE
Fondi europei regionali (FESR/FSE+)	Innovazione sanitaria, inclusione	Variabile per Regione, programmazione 2021–2027
Fondazioni bancarie	Progetti di comunità e welfare territoriale	Bandi annuali, tipicamente 20.000–150.000 €
Fondi comunali	Ristrutturazione immobile, utenze, personale ausiliario	Da negoziare con l'amministrazione

Nota: ogni area interna deve formulare una strategia d'azione tramite l'ente capofila, con il supporto della Regione. La Cabina di regia approva le strategie entro 60 giorni dal ricevimento. Questo è il canale in cui il progetto della dottoressa dovrebbe entrare.

Autorizzazioni e comodato

Aspetto	Cosa serve	Chi rilascia
Autorizzazione sanitaria	Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi	Regione o Comune su parere ASL
Accreditamento istituzionale	Solo se il presidio eroga prestazioni per conto del SSN	Regione
Agibilità dei locali	Conformità edilizia, impianti, accessibilità	Comune
Comodato immobile	Contratto scritto, durata, ripartizione oneri	Consiglio comunale
Privacy e dati sanitari	DPIA, nomina DPO, registro trattamenti	Adempimento interno

Sul comodato: attenzione a chi paga cosa. Il comodato gratuito riguarda l'uso dell'immobile, ma manutenzione straordinaria, adeguamento impianti e utenze vanno definiti nel contratto. È un punto che spesso si scopre troppo tardi.

La domanda più importante: e dopo il PNRR?

La dottoressa è stata chiara: non vuole aprire e chiudere dopo due anni. Il PNRR finanzia l'avvio, non la gestione ordinaria. Il tuo progetto deve rispondere a come si sostiene il presidio dal 2027 in poi.

- Il personale sanitario è a carico dell'ASL nella gestione ordinaria, non del progetto
- Le utenze e la manutenzione possono restare in capo al Comune, se negoziato
- I dispositivi acquistati con fondi PNRR restano di proprietà pubblica e continuano a funzionare
- I costi ricorrenti veri sono: connettività, licenze software, manutenzione dispositivi, materiali di consumo
- Fondazioni e fondi regionali possono coprire l'esercizio, ma vanno programmati prima

Le domande che la dottoressa ti farà

- "Chi presenta la domanda? Io, il Comune, o l'ASL?"
- "Quanto tempo passa dalla domanda ai soldi?"
- "Se il Comune mi dà l'immobile ma va ristrutturato, chi paga i lavori?"
- "Nel 2027 quando finisce il PNRR, chi paga la connessione e le licenze?"
- "Devo assumere qualcuno io? Con quale contratto?"

Prossimo passo — individua i canali reali e costruisci il piano post-PNRR, poi vai nella chat. La sostenibilità nel tempo è il suo tema.